福州市人民政府文件

榕政规〔2026〕9号

福州市人民政府关于印发《福州市建立健全长期护理保险制度实施方案》的通知

福州新区管委会（长乐区人民政府），各县（市）区人民政府，市人民政府各部门，市直各单位，自贸区福州片区管委会：

现将《福州市建立健全长期护理保险制度实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

福州市人民政府

2026年10月10日

（此件主动公开）

福州市建立健全长期护理保险制度实施方案

为深入贯彻党中央、国务院关于加快建立长期护理保险制度的决策部署，落实省委、省政府工作要求，更好地适应人口老龄化、社会治理现代化等形势要求，健全完善社会保障体系，满足失能人员长期护理基本保障需求，结合我市实际，制定本方案。

一、目标任务

按照建立长期护理保险制度“覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续”的总体要求和贯彻公平适度、保障基本、尽力而为、量力而行的理念，坚持独立运行、多元筹资、以收定支、收支平衡的原则，落实国家、省部署要求，在原试点基础上，2026年底前将长期护理保险制度覆盖范围扩大至未就业城乡居民，实现职工居民全覆盖；2028年底前，与我市经济发展水平相适应的长期护理保险制度更加健全完善，长期护理服务保障体系更加成熟定型。

二、统筹城乡，覆盖全民

（一）参保范围。我市用人单位（包括机关、事业单位、企业、社会组织）及其职工、退休人员、灵活就业人员和未就业城乡居民按属地管理原则参加长期护理保险。

（二）统筹层次。长期护理保险实行市级统筹，全市统一

覆盖范围、统一筹资政策、统一待遇保障、统一定点管理、统一基金收支、统一经办服务“六统一”。

（三）基金筹集。长期护理保险保费实行单位、个人、政府、社会等多元筹集机制，基金单独筹资、统一建账、统筹使用，与基本医保共同缴费。

单位职工由用人单位和职工个人共同按月缴费。鼓励灵活就业人员按单位职工费率标准参保，由个人按规定缴费；灵活就业人员也可选择按未就业城乡居民参保身份参保缴费。退休人员费率与单位职工个人费率相同，由个人缴费，原用人单位不缴费。未就业城乡居民按年缴费，实行个人缴费和财政补助相结合。18 周岁以下未就业人员跟随父母或法定抚养人等参保，不单独筹资，按规定享受未就业城乡居民长期护理保险待遇。孤儿、事实无人抚养儿童等无法跟从参保的，视同参保。职工基本医疗保险个人账户可以用于本人及近亲属参加长期护理保险的个人缴费。除中央和省级财政补助外，市、县（市）区政府长期护理保险财政补助部分参照城乡居民基本医疗保险筹资分担比例分担。鼓励通过慈善捐赠等渠道，对特定人群参加长护险的个人缴费部分给予资助。

（四）筹资标准。2027 年 1 月 1 日起，长期护理保险费率统一为 0.3%，缴费基数按参保人员类型分别确定。

1.单位职工。单位职工的长期护理保险费率为 0.3%，由用

人单位和职工个人按1:1比例共同缴费，其中用人单位按单位职工工资总额的0.15%缴费，职工个人以其本人工资收入的0.15%缴费。工资总额的构成以国家统计局规定为准，缴费基数及上下限按职工基本医疗保险缴费基数执行。从职工基本医疗保险的单位费率8%中调整出0.15%作为长期护理保险单位费率。

2.退休人员。按其本人月基本养老金的0.15%缴费，经本人同意，费款从其职工基本医疗保险个人账户代扣代缴。

3.灵活就业人员。已参加职工基本医疗保险的灵活就业人员，按单位职工费率标准参保缴费的，缴费基数执行灵活就业人员参加职工基本医疗保险的基数。

灵活就业人员以未就业城乡居民身份参保的，按未就业城乡居民参保政策参保缴费。

4.未就业城乡居民。原则上以我市公布的上年度城乡居民人均可支配收入为基数筹资，长期护理保险制度覆盖至居民的起步阶段按0.15%筹资，5年时间过渡到0.3%。个人与财政补助按1:1比例分担。

5.特殊群体。对符合条件的困难人群个人缴费部分由财政予以分类资助，资助对象、资助标准及资助资金的市、县（市）区财政分担比例参照我市医疗救助政策规定执行。困难大学生参照城乡居民基本医疗保险资助政策执行。

大学生个人缴费部分可由财政资金给予一定比例的参保资助，具体资助标准由市医保部门会同财政部门协商后报市政府研究确定。

积极探索通过金融机构、通信运营商等开展“积分兑保费”、权益置换等多元筹资方式资助参加长期护理保险。

三、坚持公平适度保障

（一）待遇享受对象。按规定参保缴费且失能状态长期持续（一般为6个月以上），经申请通过评估认定的失能人员，按规定享受相关待遇。职工长期护理保险制度当前失能保障对象范围保持不变。居民长期护理保险制度起步阶段，先行保障重度失能人员，今后若国家、省扩大保障对象范围，从其规定。

（二）待遇支付标准。依据不同失能等级、服务方式实行差别化待遇保障政策。

1.起付标准。长期护理保险待遇享受不设起付标准。

2.支付比例。符合规定的长期护理服务费用，按单位职工政策参保的，机构护理、社区护理、居家护理的基金支付比例分别为75%、80%、85%；按未就业城乡居民参保政策参保的，机构护理、社区护理、居家护理的基金支付比例分别为50%、55%、60%。灵活就业人员依据其选择的参保政策类型享受相应待遇。支持基层医疗机构利用闲置床位，提供长期护理保险服务，基金支付比例参照社区护理执行。

3.待遇核定。长期护理保险待遇水平根据我市经济社会发展水平、基金收支情况等实行动态调整，参保人员年度内基金最高支付限额不超过我市上年度城乡居民人均可支配收入的50%，具体待遇标准由医保部门会同财政部门研究制定。

（三）基金支付范围。长期护理保险基金主要用于支付符合规定的定点护理服务机构和人员提供长期护理基本服务所发生的费用，以及符合规定的失能等级评估和引入社会力量参与经办的服务费用。原则上不得直接向失能人员发放现金。

1.落实国家统一的长期护理保险服务项目目录，原试点服务项目目录在3年内过渡至国家统一标准。按国家、省统一部署，探索将支持性辅助器具、智能化服务等逐步纳入支付范围。

2.根据国家、省统一部署，做好长期护理保险与经济困难的高龄、失能老年人补贴及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。领取工伤保险生活护理费的参保人员，不重复享受长期护理保险相关服务待遇。

3.下列费用不纳入长期护理保险基金支付范围：

（1）机构床位费、膳食费等非护理服务费用；

（2）不符合规定的长期护理服务机构、评估机构和人员提供服务的费用；

（3）应由医疗保险支付的医疗费用；

（4）应由第三方依法承担的护理费用；

（5）在境外发生的护理费用;

（6）法律法规和国家政策规定的其他不予支付的费用。

4.享受长期护理保险待遇的参保人员出现下列情形之一的，终止或中止待遇享受:

（1）参保人员死亡的;

（2）经重新评估不再符合待遇享受条件的;

（3）参保人员中止参保或中断缴费的;

（4）住院治疗期间;

（5)法律法规和国家政策规定终止或中止待遇享受的其他情形。

（四）激励约束机制。建立缴费时长和待遇水平相挂钩的参保激励约束机制，并根据国家部署，优化调整激励约束措施。

1.实行连续参保激励。从我市长期护理保险制度覆盖至居民的当年起，对连续参加长期护理保险满 4 年的未就业城乡居民，之后每连续参保 1 年，每年提高基金支付比例 1 个百分点，基金最高支付比例不超过 60%。断保之后再次参保的，连续参保年数重新计算，原积累的连续参保激励不保留。

2.落实待遇等待期政策。2027 年 1 月起，除新生儿、当年退役军人、被资助参保对象等特殊群体外，对未在我市长期护理保险制度职工、居民全覆盖时参保的初次参保人员、中断缴费超过 3 个月或中断 3 个月内未补缴的单位职工(含退休人员、

按单位职工政策参保的灵活就业人员）、未连续参保的未就业城乡居民等，从参保关系生效当月开始设置6个月固定待遇等待期，并随着断保年限的增加相应延长变动等待期，等待期内不享受待遇。

3.其他规定。长期护理保险保费退费和不予退费的具体情形参照基本医疗保险相关规定执行。

四、规范管理服务体系

（一）健全评估管理。落实全国统一的失能等级评估标准。长期护理保险失能等级评估机构实行定点管理，支持发展专业独立的社会化评估机构。落实评估服务费由基金和个人合理分担机制。建立健全评估人员规范化培训机制，培训费用按规定标准列入财政预算。强化评估质量，实行评估前申请人信息比对前置调查、评估过程管控、评估结果复核、评估结论公示、待遇享受期间分类确定监管等级的闭环管理。探索发挥家庭签约医生和智能辅助设备在失能等级评估中的作用。推动建立长期护理保险评估结果跨部门共享机制。

（二）规范服务支付。长期护理服务机构实行定点管理。编制与我市长期护理保险事业发展需求相适应的定点资源配置规划，建立适应不同服务模式的支付方式，探索实施与长期照护师职业技能等级相衔接的差异化支付机制。完善长期护理保险服务质量评价和监督制度，健全费用控制激励约束机制。

（三）严格基金管理。长期护理保险基金纳入社会保险基金财政专户管理，单独建账、单独管理、专款专用。科学编制基金收支预算，强化预算执行全过程监控和绩效评价。完善监管体系与定点服务协议管理，探索推行信用管理制度，健全多部门协同监管机制。在长期护理保险基金出现支付困难时，按照规定及时调整筹资和待遇政策。

（四）优化经办服务。落实社会保险费征收体制改革要求，税务部门负责基金征收，医保经办机构完善参保登记。加强评估机构和护理机构定点服务协议管理，对于护理服务覆盖不足的，探索实施就近化便捷化的护理服务方式。依法依规通过公开招标等竞争性方式引入第三方社会力量参与经办管理服务，相关费用依协议约定从长期护理保险基金中支付，完善对引入的第三方经办机构的考核评价。不得将基金交由受托经办业务的第三方机构代管代拨。根据国家、省统一部署，做好跨统筹区长期护理保险关系转移接续、结果互认、待遇享受等工作。强化医保信息平台长期护理保险子系统应用和福州专区特色功能建设，推进跨部门信息系统互联互通、数据共享。

（五）培育长护市场。大力发展和培育长期护理服务市场，倡导居家、社区护理。对基层医疗机构拓展长期护理服务试点的，医保、卫健部门在基金支付、绩效分配等方面予以支持。拓宽长期护理人才培养渠道，完善护理人员岗前和技能提升培

训机制，开展在榕职业院校相关专业学生长期护理前置培训，推动学生“毕业即执证”，相关培训费用纳入财政预算；鼓励长期护理服务人员参加长期照护师职业技能等级认定。鼓励商业保险公司开发与长期护理保险相衔接的商业补充保险产品，满足参保群众多样化、多层次的护理需求。

五、组织保障

医保部门牵头组织实施长期护理保险制度和相关配套政策。财政部门会同有关部门做好基金预决算管理，落实各项补助资金。民政部门推动养老服务体系建设，做好养老服务消费补贴与长期护理保险的待遇衔接工作。人社部门配合主管部门推动开展长期照护师职业技能培训评价，协调做好退休人员养老金数据共享工作，引导定点长期护理服务机构完善与技能等级相适应的薪酬分配制度，做好与工伤保险政策的衔接。卫健部门引导基层医疗机构积极参与长期护理服务试点工作，对提供长期护理服务的基层医疗机构给予政策支持，并进行医疗行业管理和监督。市场监管部门负责对提供长期护理服务机构的价格行为进行监管。税务部门建立完善征缴机制，及时足额征收保费，优化缴费服务。农业农村部门负责做好防止返贫致贫对象认定和帮扶工作。残联协同做好残疾人参保相关工作，配合民政部门做好重度残疾人护理补贴对象的审核认定工作。金融监管部门做好参与经办的商业保险机构市场行为的监管，引

导相关商业补充保险发展。数据管理部门督促推进各部门之间的数据汇聚共享。公安机关负责加大对长期护理保险基金管理领域违法犯罪的刑事打击力度，做好涉长期护理保险违法违规案件的行刑衔接。福州新区管委会（长乐区人民政府）、各县（市）区人民政府要压实责任，把建立完善长期护理保险制度作为重要民生工程，强化组织领导，建立部门联动机制，加强政策宣传、舆论引导和参保发动，强化市场培育和服务供给，确保长期护理保险各项工作积极稳妥推进、有力有效落实。

本方案自印发之日起施行，有效期与省方案保持一致。实施过程中，如国家、省对长期护理保险政策进行调整的，从其规定。我市既往相关规定与本方案不符的，按本方案执行。《福州市人民政府关于印发福州市深入推进长期护理保险制度试点实施方案的通知》（榕政规〔2023〕15号）同时废止。本方案相关事项的具体实施办法或细则由市医保部门会同相关部门另行制定。

福州市人民政府办公厅　　2026年10月12日印发